

I Disturbi di Personalità – Schema

Salute Mentale · Sessione 08

Personalità: componenti di base

- **Temperamento** → tratti congeniti, biologici; risposta emotiva agli stimoli
 - Influenzato da genetica + fattori prenatali/perinatali
 - **Relativamente stabile ma non immutabile**
 - **Carattere** → tratti acquisiti dall'interazione con l'ambiente; modellato dall'esperienza
 - **Personalità** → temperamento + carattere
 - = modalità stabili di: **pensare · sentire · comportarsi · relazionarsi**
-

9 variabili temperamentali (Thomas, Chess & Birch, 1968)

- **Livello di attività** → quantità di movimento spontaneo
- **Regolarità biologica** → prevedibilità di sonno, alimentazione, defecazione
- **Approccio/Ritiro** → reazione alle novità
- **Adattabilità** → risposta ai cambiamenti
- **Sensibilità agli stimoli** → soglia di risposta sensoriale
- **Intensità delle reazioni** → forza dell'espressione emotiva
- **Qualità dell'umore** → prevalenza di stati positivi o negativi
- **Distraibilità** → facilità di distrazione
- **Persistenza** → durata dell'attenzione e tolleranza alla frustrazione

Tipologie infantili: - Bambini **facili** → ritmi regolari, umore positivo, adattabili - **Bambini difficili (~10%)** → caratteristiche opposte - Bambini a **lenta attivazione** → risposte attenuate, adattamento lento

Goodness of fit → armonia tra temperamento del bambino e risposte dell'ambiente

Modelli di tratti

- **Eysenck**: estroversione · nevroticismo · psicoticismo (abbandonato)
 - **Big Five** (Costa & McCrae, 1988):
 - Estroversione
 - Nevroticismo
 - **Gradevolezza** → calore vs cinismo
 - **Coscienziosità** → autocontrollo vs impulsività
 - **Apertura all'esperienza** → curiosità vs convenzionalità
 - **Corazza caratteriale** (Reich) → stili difensivi abituali formati nell'infanzia
-

Tratto vs Stato

- **Tratto** → stabile nel tempo e nelle situazioni → base dei disturbi di personalità
 - **Stato** → temporaneo, reattivo → base delle sindromi cliniche (es. depressione maggiore)
-

Da stile a disturbo

- **Stile** → tratti adattivi, non compromettono il funzionamento
- **Disturbo** → tratti rigidi, pervasivi → sofferenza e/o compromissione significativa

Modello bio-psico-sociale (Paris, 1997): - Fattori **biologici** → temperamento, neuropsicologia - Fattori **psicologici** → traumi, accudimento abnorme - Fattori **sociali** → disgregazione valori, riti iniziatici assenti - **Diatesi** (vulnerabilità) + **stress** = disturbo

Definizione DSM-5-TR

Pattern che: - **Devia** dalle aspettative culturali - È **pervasivo e inflessibile** in molteplici situazioni - Causa **disagio** o **compromissione** significativa - È **stabile** nel tempo; esordio in **adolescenza o prima età adulta**

Aree interessate (almeno 2): **Cognitività** · **Affettività** · **Funzionamento interpersonale** · **Controllo degli impulsi**

- **Egosintonia** → tratti non percepiti come problematici → **scarsa motivazione al trattamento**
 - **Spettro internalizzante** → soffrono dentro, si incolpano (evitante, dipendente, schizoide)
 - **Spettro esternalizzante** → fanno soffrire gli altri, incolpano gli altri (paranoide, narcisistico, antisociale)
 - **BPD** → **oscilla tra i due spettri**
-

Cluster A — Strani ed eccentrici

Paranoide

- **Nucleo** → **diffidenza e sospettosità pervasive**; motivazioni altrui = malevole
- **Criteri** → sospetta di essere sfruttato/ingannato · non si confida · porta rancore · reattività rabbiosa · gelosia infondata
- **Credenza sé** → "Sono costantemente in pericolo"
- **Credenza altri** → "Il mondo è pieno di persone pronte ad attaccarmi"
- **Difese** → proiezione · identificazione proiettiva · diniego · formazione reattiva

Schizoide

- **Nucleo** → **distacco pervasivo dalle relazioni**; **gamma emotiva ristretta**
- **Criteri** → non desidera relazioni strette · attività solitarie · nessun amico stretto · indifferente a lodi/critiche · freddo emotivamente
- **Difesa** → ritiro (comportamentale e in fantasia)

Schizotipico

- **Nucleo** → deficit sociali + distorsioni cognitive/percettive + eccentricità
 - **Nota** → disturbo di personalità più vicino alla psicosi; contatto con realtà ancora presente
-

Cluster B — Drammatici, emotivi, imprevedibili

Antisociale

- **Nucleo** → violazione pervasiva dei diritti altrui
- **Criterio temporale** → disturbo della condotta prima dei **15 anni**
- **Difesa** → controllo onnipotente

Borderline (BPD)

- **Nucleo** → instabilità di relazioni, identità e umore + marcata impulsività
- **Prevalenza** → ~20% dei pazienti psichiatrici (Gunderson & Links, 2015)
- **Criteri:**
 - Sforzi disperati per evitare l'abbandono (reale o immaginario)
 - Relazioni intense e instabili → idealizzazione ↔ svalutazione
 - Identità instabile e persistentemente discontinua
 - Impulsività in aree dannose (spese, sessualità, sostanze, guida, abbuffate)
 - Comportamenti automutilanti o minacce suicidarie (80% dei ricoverati)
 - Instabilità affettiva rapida (≠ bipolare: cicli molto più brevi)
 - Sentimenti cronici di vuoto
 - Rabbia inappropriata e intensa
 - Ideazione paranoide transitoria / sintomi dissociativi sotto stress
- **Difese** → scissione · identificazione proiettiva · diniego · dissociazione · acting out

Istrionico

- **Nucleo** → emotività eccessiva + ricerca pervasiva di attenzione

- **Criteri** → disagio se non al centro · seduttività inappropriata · emotività mutevole e superficiale · usa l'aspetto fisico · eloquio impressionistico · drammatizzazione · suggestionabilità · considera relazioni più intime di quanto siano
- **Difese** → difese prevalentemente isteriche (repressione, sessualizzazione)

Narcisistico

- **Nucleo** → grandiosità + bisogno di ammirazione + mancanza empatia (emotiva)
 - **Difese** → idealizzazione · svalutazione
-

Cluster C — Ansiosi e inibiti

Evitante

- **Distinzione da schizoide** → l'evitante *vuole* le relazioni; lo schizoide no
- **Distinzione da ansia sociale** → qui è un tratto stabile di personalità, non una fobia

Dipendente

- **Nucleo** → bisogno pervasivo di essere accuditi + sottomissione + paura separazione

Ossessivo-Compulsivo di Personalità (DOCP)

- **Nucleo** → ordine + perfezionismo + controllo interpersonale a spese di flessibilità
 - **Distinzione da DOC** → nel DOCP non ci sono ossessioni né compulsioni vere; è egosintonico
-

Il problema diagnostico

- DSM → approccio **categoriale** (sì/no) ↔ disturbi psicologici sono **dimensionali**
 - Problema → alta comorbidità, casi sotto soglia, categorie artificiali
 - Studio Shea et al. (1999) → veterani di guerra con PTSD: 82-90% criteri paranoide, 52-92% criteri borderline
 - **PDM-2** (Lingiardi & McWilliams) → alternativa più dimensionale e psicodinamica
-

Organizzazione di personalità (Kernberg)

"**Borderline**" in senso estensivo = livello strutturale intrapsichico (non solo diagnosi DSM)

Struttura	Identità	Difese	Esame di realtà
Nevrotica	Integrata	Mature	Conservato
Borderline	Diffusa	Primitive	Conservato (vacilla sotto stress)
Psicotica	Gravemente compromessa	Primitive	Perduto

3 criteri per l'organizzazione borderline: 1. **Diffusione dell'identità** → sé e altri poco integrati; percezioni contraddittorie 2. **Difese primitive** → scissione come meccanismo centrale (tutto buono / tutto cattivo) 3. **Esame di realtà conservato** → distingue interno/esterno; non delira in modo persistente

Organizzazione borderline sottende grosso modo i disturbi dei **cluster A e B**.

Trattamenti validati per BPD

- **DBT** (Linehan) → dialettico-comportamentale; tolleranza emozioni; strategie interpersonali
- **MBT** → basata sulla mentalizzazione
- **TFP** (Kernberg) → basata sul transfert

Autori / Date / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
Thomas, Chess & Birch	9 variabili temperamentali; tipologie bambini (facili/difficili/lenta attivazione)	1968/1977
Eysenck	Modello a 3 fattori (estroversione, nevroticismo, psicoticismo)	1968
Costa & McCrae	Big Five	1988
Reich	Corazza caratteriale	1897-1957
McWilliams	Tipologie di personalità e meccanismi difensivi	1994
Paris	Modello bio-psico-sociale dei disturbi di personalità	1997
Gunderson & Links	BPD = ~20% dei pazienti psichiatrici	2015
Linehan	Definizione BPD "ustioni di terzo grado"; DBT	—
Kernberg	Organizzazione di personalità borderline; TFP	1967/1987
Lingiardi & McWilliams	PDM-2; credenze patogene; meccanismi difensivi	2018
APA	DSM-5-TR	2023
Schneider	Disturbo = sofferenza propria o altrui	1958

Chi	Cosa	Quando
Shea et al.	Studio comorbidità su veterani PTSD	1999

Parole chiave

temperamento · carattere · personalità · tratto · stato · goodness of fit · diatesi · corazza caratteriale · egosintonia · scissione · identificazione proiettiva · diffusione dell'identità · organizzazione borderline · cluster A/B/C · DSM-5-TR · PDM-2 · Big Five · BPD · DBT